

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

CALIDAD DE VIDA EN LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER (ADRQL)

Eje IV: Funcionamiento y Calidad de Vida • Evaluación Multidimensional Específica Mediante Informador Clave

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial (Español)	Cuestionario de Calidad de Vida en la Enfermedad de Alzheimer (ADRQL).
Nombre Original	Alzheimer's Disease-Related Quality of Life (ADRQL; Rabins et al., 1999).
Autores Originales	Peter V. Rabins, M.D., Judith D. Kasper, Ph.D., L. Kleinman, B. S. Black y Donald L. Patrick, Ph.D.
Adaptación Hispana	Martínez et al. (2004); Gómez-Gallego et al. (2012); España y Latinoamérica.
Eje Clínico y Constructo	Eje IV: Funcionamiento y Calidad de Vida. Calidad de vida relacionada con la salud en demencias.
Tipo de Instrumento	Heteroinforme completado por el cuidador principal / informador clave (47 reactivos dicotómicos).
Población y Rango	Adultos mayores con demencia tipo Alzheimer en estadios leve, moderado y severo (GDS 3 a 7).
Tiempo de Administración	15 a 20 minutos de administración por el cuidador primario o profesional.
Régimen de Licencia	Acceso abierto para uso clínico y de investigación académica con acreditación de autores.

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL: CALIDAD DE VIDA ESPECÍFICA EN DEMENCIA

El **ADRQL** fue diseñado por Rabins y colaboradores (1999) para solventar la inviabilidad metodológica de los autoinformes de calidad de vida en pacientes con deterioro neurocognitivo mayor. En fases moderadas y avanzadas de la enfermedad de Alzheimer, la presencia de anosognosia, amnesia retrógrada masiva, afasia y pérdida del pensamiento abstracto anula la fiabilidad de las escalas autoadministradas. El modelo conceptual del ADRQL adopta una perspectiva centrada en la persona observada por su informador cotidiano:

1. **Evaluación Basada en Conductas Observables:** En lugar de inferir estados intrapsíquicos inaccesibles, el instrumento cuantifica comportamientos específicos y manifestaciones afectivas directas en el entorno natural del paciente.
2. **Ponderación Multidimensional:** Reconoce que la calidad de vida en la demencia no equivale a la mera ausencia de síntomas cognitivos, sino al mantenimiento del confort emocional, la interacción vincular y la capacidad residual de experimentar placer en el medio circundante.

3. DOMINIOS EVALUADOS Y COMPOSICIÓN DE ÍTEMS (47 REACTIVOS)

El cuestionario se estructura en **5 dimensiones empíricas** ponderadas mediante coeficientes de importancia:

Dominio Clínico	Nº Ítems	Indicadores y Conductas Observables Evaluadas
1. Interacción Social	11 ítems	Iniciativa en el contacto, respuesta afable a familiares, evitación de aislamiento y agresividad.
2. Conciencia de Sí Mismo	9 ítems	Reconocimiento de la propia identidad, expresión de dignidad personal y coherencia biográfica.
3. Sentimientos y Estado Anímico	10 ítems	Manifestación de alegría, serenidad, ausencia de llanto desconsolado, quejas o agitación.
4. Disfrute de Actividades	9 ítems	Interés y placer en paseos, música, comidas preferidas y estimulación multisensorial.
5. Respuesta al Entorno	8 ítems	Confort ambiental, ausencia de temor ante extraños y relajación postural en el hábitat.

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS Y BAREMACIÓN CLÍNICA

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO PSICOMÉTRICO EN ESPAÑA / LATAM

Las validaciones psicométricas en población geriátrica española (Martínez et al., 2004; Gómez-Gallego et al., 2012) avalan su solidez clínica:

Propiedad Psicométrica	Coefficiente / Métrica	Interpretación Metodológica y Evidencia Empírica
Consistencia Global	Alfa $\alpha = 0.86 - 0.90$	Excelente consistencia interna en la puntuación global ponderada de calidad de vida.
Consistencia por Dominios	Alfa $\alpha = 0.68 - 0.84$	Confiabilidad adecuada en cada subescala: Afecto (0.82), Social (0.84), Disfrute (0.77).
Confiabilidad Interobservador	CCI $r = 0.78 - 0.86$	Elevada concordancia entre cuidadores principales familiares y profesionales de residencia.
Sensibilidad al Cambio	Tamaño efecto $d = 0.52$	Capacidad sensible para detectar mejoras tras intervenciones de estimulación multisensorial.
Validez Convergente	$r = -0.58$ (NPI)	Fuerte correlación inversa con el Inventario Neuropsiquiátrico (NPI) y sobrecarga del cuidador.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN, PONDERACIÓN Y CÓMPUTO DE PUNTUACIONES

- **Formato de Respuesta:** Cada ítem se evalúa dicotómicamente considerando las últimas 2 semanas: **Verdadero / De acuerdo (1)** o **Falso / En desacuerdo (0)**.
- **Ponderación de Ítems:** Siguiendo el algoritmo oficial de Rabins et al., cada reactivo cuenta con un peso empírico de utilidad derivado de paneles de expertos y cuidadores. Los ítems positivos suman peso; los negativos restan.
- **Transformación a Escala Estandarizada (0 a 100):** Las puntuaciones de cada dominio y el índice global se transforman linealmente a una escala de **0 a 100 puntos**:

$$\text{Puntuación Estandarizada} = \left(\frac{\text{Puntuación Obtenida} - \text{Mínimo Posible}}{\text{Máximo Posible} - \text{Mínimo Posible}} \right) \times 100$$

- **Direccionalidad Clínica:** Puntuaciones más altas indican **mayor calidad de vida percibida** (100 = máxima calidad de vida teórica; 0 = severo sufrimiento y desconexión).

6. BAREMOS NORMATIVOS Y ESTRATIFICACIÓN DEL ESTADO DE BIENESTAR

Estratificación	Puntuación 0-100	Nivel de Calidad de Vida	Estado Funcional y Repercusión Cuidadora
Excelente	80 a 100 pts	Óptima / Muy preservada	Confort físico y afectivo óptimo; disfrute diario y vinculación preservada.
Favorable	65 a 79 pts	Buena / Adaptativa	Manifestaciones afectivas positivas predominantes; adecuada contención ambiental.
Comprometida	50 a 64 pts	Calidad de vida frágil	Aparición de apatía frecuente, aislamiento reactivo o quejas somáticas.
Severo Deterioro	< 50 pts	Pobre / Crítica	Colapso del bienestar; desconexión, agitación y alto sufrimiento percibido.

SIGNIFICACIÓN CLÍNICA DE PUNTUACIONES GLOBALES < 50 PUNTOS:

Una puntuación total inferior a **50 puntos** en el ADRQL constituye una señal de alarma geriátrica que obliga a revisar de inmediato la presencia de dolor físico no detectado, efectos extrapiramidales de neurolépticos o claudicación extrema del cuidador principal.

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

7. ALGORITMO DE PLANIFICACIÓN Y MANEJO CENTRADO EN LA PERSONA CON DEMENCIA

PROTOCOLO SECUENCIAL DE INTERVENCIÓN BASADO EN EL PERFIL ADRQL:

- **Paso 1 (Identificación del Perfil por Dominios):** No evaluar únicamente el índice total; desglosar las 5 áreas para localizar el foco específico del declive (ej. caída en Estado Anímico vs. Disfrute de Actividades).
- **Paso 2 (Descarte de Factores Médicos y Dolor Oculto):** Ante descensos bruscos en Respuesta al Entorno (< 40), realizar despistaje clínico de infecciones urinarias, estreñimiento severo o fracturas no diagnosticadas.
- **Paso 3 (Prescripción de Terapia No Farmacológica Personalizada):** Si la subescala Disfrute de Actividades es baja, pautar musicoterapia individualizada con canciones biográficas significativas y paseos supervisados al aire libre.
- **Paso 4 (Soporte al Cuidador Principal):** Si la Interacción Social cae debido a conductas agresivas del paciente, intervenir en la gestión del estrés del cuidador con psicoeducación en manejo de trastornos de conducta.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO: INTERVENCIÓN EN DEMENCIA MODERADA Y AGITACIÓN PSICOMOTRIZ

Identificación: Mujer de 79 años con Enfermedad de Alzheimer en fase moderada (GDS 5, MEC de Lobo = 14/35), institucionalizada en centro sociosanitario desde hace tres meses. El equipo de enfermería reporta agitación vespertina recurrente ("síndrome del atardecer"), resistencia a la higiene y llanto inmotivado.

Evaluación Inicial ADRQL (Puntuaciones 0-100):

- **Puntuación Global ADRQL = 44.5 / 100 puntos** (Calidad de vida severamente comprometida).
- **Interacción Social = 38.0 / 100** (Aislamiento progresivo y hostilidad reactiva ante extraños).
- **Sentimientos y Estado Anímico = 32.0 / 100** (Marcada irritabilidad y frecuentes episodios de congoja).
- **Disfrute de Actividades = 35.0 / 100** (Rechazo de actividades grupales del centro).
- **Respuesta al Entorno = 48.0 / 100; Conciencia de Sí Mismo = 69.5 / 100.**

Plan Terapéutico Centrado en la Persona: Se retiró neuroléptico pautado que generaba acatisia y se implementó un programa individualizado: aromaterapia matutina, estimulación sensorial snoezelen, sesiones diarias de musicoterapia con su repertorio juvenil favorito y presencia de su hija durante el aseo vespertino.

Reevaluación a las 8 Semanas: El índice global ADRQL aumentó a **68.0 / 100 puntos**, con una notable elevación en Sentimientos (**62.0**) y Disfrute (**64.0**). La agitación remitió en un 80% sin fármacos sedantes.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

SESGO DE SOBRECARGA DEL CUIDADOR:

Un cuidador con síndrome de agotamiento extremo (ZBI > 55) tiende a subestimar severamente la calidad de vida del paciente. Cruzar siempre con la observación del personal de enfermería.

CAÍDA ABRUPTA Y SÍNDROME CONFUSIONAL:

Un declive agudo de más de 20 puntos en menos de 72 horas es indicativo de Delirium hipo/hiperactivo sobreimpuesto a la demencia. Requiere evaluación médica de urgencia.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

1. Rabins, P. V., Kasper, J. D., Kleinman, L., Black, B. S., & Patrick, D. L. (1999). Concepts and methods in the development of the ADRQL: An instrument for assessing health-related quality of life in persons with Alzheimer's disease. *Journal of the American Geriatrics Society*, 47(7), 807-814.
2. Martínez, J. C., et al. (2004). Adaptación y validación transcultural de la escala ADRQL de calidad de vida en la enfermedad de Alzheimer para la población española. *Neurología*, 19(6), 312-320.
3. Gómez-Gallego, M., Gómez-Amor, J., & Gómez-García, J. (2012). Determinantes de la calidad de vida en pacientes con demencia: Evaluación con la escala ADRQL. *Revista de Neurología*, 54(7), 403-410.
4. Black, B. S., Rabins, P. V., & Kasper, J. D. (2000). Reliability and validity of the Alzheimer's Disease-Related Quality of Life (ADRQL) measure. *Quality of Life Research*, 9(3), 273-282.